Patientenrechtegesetz

Revolution ?

Oder viel Lärm um nichts?

Ausgangslage

„Patientenrechte sind in Deutschland derzeit in einer Vielzahl von Vorschriften in verschiedenen Rechtsbereichen – zum Teil lückenhaft – geregelt. Auf dem Gebiet des Behandlungs- und Arzthaftungsrechts steht Wesentliches nicht im Gesetz, sondern ist Richterrecht“

Patientenrechtegesetz

Kein gesondertes Gesetz

„Nur“

- Neuer Abschnitt im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) mit der Überschrift „Behandlungsvertrag“

- Die wichtigsten „Patientenrechte“ sind in §§ 630 a – 630 h BGB normiert

Patientenrechtegesetz

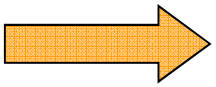
Die wesentlichen Regelungen

- Rechtsnatur des Behandlungsvertrages
- Informationspflichten
- Aufklärungspflichten
- Dokumentationspflichten
- Beweislastregeln

Patientenrechtegesetz

Nicht normiert aber:

- Entschädigungsfond
- Weitere Beweiserleichterungen
- Generelle Beweislastumkehr



SPD „Seifenblase“

Linke „Placebo“

Die wesentlichen Regelungen

Behandlungsvertrag, § 630 a BGB

- Auch weiterhin kein Erfolg (der Behandlung) geschuldet
- „Nur“ Behandlung nach allgemein anerkannten fachlichen Standards

Exkurs:

- Grds. auch bei sog. „Schönheits-OP“, es sei denn, anders vereinbart.

Die wesentlichen Regelungen



Behandlungsvertrag = Dienstvertrag



Arzt trägt als Behandler grundsätzlich keine Erfolgsverantwortung, sondern schuldet subjektive Mühewaltung („sich nach Kräften bemühen“)

Grundsätzlich auch keine Abmahnung oder Kündigung wg. eines Behandlungsfehlers, es sei denn, nachweisbare und für Schaden kausale Verletzung der erforderlichen Sorgfalt nach anerkannten med.-wiss. Erkenntnissen.

„Misserfolg“ reicht als Argument weiterhin nicht aus.

Die wesentlichen Regelungen

Informationspflichten, § 630 c BGB

Differenzierung nötig:

1) Behandlungsinformation gem. § 630 c Abs. 2 Satz 1 BGB
2) Information über Behandlungsfehler gem. § 630 c Abs. 2 Satz 2 BGB
3) Wirtschaftliche Information gem. § 630 c Abs. 3 BGB

Die wesentlichen Regelungen

Behandlungsinformation

Gesetzesbegründung:

„Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur therapeutischen Aufklärung und zur Sicherungsaufklärung sollen festgeschrieben werden. Die Informationen sollen nicht Selbstzweck sein, sondern dafür sorgen, dass der Patient eigenverantwortlich und selbstbestimmt im Rahmen der Behandlung entscheiden kann.“

Nichts neues!

Die wesentlichen Regelungen

Information über Behandlungsfehler, § 630 c Abs. 2 Satz 2 BGB

„Sind… Umstände erkennbar, die die Annahme eines Behandlungsfehlers begründen, … über diese auf Nachfrage oder zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren zu informieren“

Zwei Fallkonstellationen

Die wesentlichen Regelungen

Information über Behandlungsfehler, § 630 c Abs. 2 Satz 2 BGB

- Zur Abwendung gesundheitlicher Gefahren
  - ⇒ **Nichts neues!**
- Auf Nachfrage des Patienten
  - ⇒ Sowohl bei eigenen möglichen Fehlern als auch bei vor- oder mitbehandelnden Ärzten

⇓

Selbst- und Fremddenunziationspflicht!

Die wesentlichen Regelungen

Information über Behandlungsfehler, § 630 c Abs. 2 Satz 2 BGB

Verhaltensempfehlungen:

- „…Umstände erkennbar…“ → Restriktive „Aussage“
- Einschränkende Auslegung möglich, da rechtliche Bewertung schon für Juristen oft schwierig
- Nur Mitteilung medizinischer Fakten **ohne** rechtliche Bewertung
- Immer vorherige Abstimmung mit Arbeitgeber und/oder Einbindung der Versicherung, ggf. nach Einholung vorherigen Rechtsrates

Die wesentlichen Regelungen

Wirtschaftliche Informationen, § 630 c Abs. 3 BGB

- Selektiv schon immer existent
- Insbes. bei sog. IGEL-Leistungen und bei von der PKV als med. nicht erforderlich / nicht erstattungsfähig anzusehend
- Nur bei echtem *„Informationsvorsprung“* wg. *„täglichen Umgangs mit derartigen Sachverhalten“*
- Information in Textform (Angestellte Ärzte sollten hierzu Dienstanweisungen verfassen)

Aber:

- **Kein** „konkreter Kostenvoranschlag“
- Pflicht entfällt bei „echten Selbstzahlern“

Die wesentlichen Regelungen

Aufklärungspflichten, § 630 e BGB

- Ausreichende Überlegungszeit
- Behandlungsalternativen
- Abschriften von Unterlagen (Aufklärung und Einwilligung) aushändigen
- Person des Aufklärenden (Auch nicht neu, aber fast)

Exkurs: Aufklärung

- Aufklärung ist Hauptpflicht des Arztes aus dem Behandlungsvertrag
- Umfassend, verständlich und rechtzeitig muss die Aufklärung sein.
- Ohne wirksame Aufklärung keine wirksame Einwilligung des Patienten.

➡ Schadenersatzpflicht und Schmerzensgeld

Exkurs: Aufklärung

- **Hohe Relevanz der Aufklärungsrüge in Arzthaftungs-prozessen (bis zu 1/3 aller Fälle?)**
- **Aufklärungsrüge ist erfolgversprechender Angriff, da Beweislast bei Behandlungsseite**
- **Patient versteht nicht/begrenzt und erinnert sich nicht**
- **„Rettungsanker“ für „tragische Fälle“ iS v. Billigkeitsurteilen**

Exkurs: Aufklärung

MedR 2007, S.88 ff.:

Befragung von 100 chirurg. Assistenzärzten

- Teil des Studiums: 5 %
- Selbst beigebracht: 15 %
- Von anderem AssArzt beigebracht: 73 %
- Von OA beigebracht: 12 %
- Über OP aufgeklärt, an der bisher weder selbst teilgenommen noch selbst durchgeführt: 100 %

Exkurs: Aufklärung

Wer muss aufklären?

- Der Behandler/Operateur selbst, aber Delegation ist zulässig, sofern auf einen Arzt delegiert wird.

➡ Fehler des aufklärenden Arztes bei der Aufklärung kann aber dem Behandler zugerechnet werden.

Exkurs: Aufklärung

BGH, Urteil vom 07.11.2006 (AZ: VI ZR 206/05)

- BGH stellt strenge Anforderungen
- Operateur darf sich nicht auf die richtige Aufklärung des nachgeordneten Arztes verlassen
- Vielmehr gelten besondere Kontrollpflichten für den Operateur als für die Organisation der Aufklärung Verantwortlichem.

Exkurs: Aufklärung

Empfehlung

- Möglichst selbst aufklären → **Königsweg**
- Bei Delegation klare Vorgaben und Stichprobenkontrollen
- Möglichst nur auf für die Behandlung besonders qualifizierte Fachärzte delegieren
- Vorgehen und Kontrollen umfassend dokumentieren

Die wesentlichen Regelungen

Dokumentationspflichten, §§ 630 f u. g BGB



BAG, Urteil vom 17.06.1998 – 2 AZR 599/97

„..., dass eine ordnungsgemäße Dokumentation sämtlicher ärztlicher Maßnahmen heute im Arzthaftungsrecht von ausschlaggebender Bedeutung für die Entlastung des Krankenhausträgers…Es ist somit erforderlich, dass die Dokumentation jeweils vollständig bis spätestens zum Ende des einzelnen Behandlungsabschnittes vorliegt. Geschehe dies nicht oder werde gar falsch dokumentiert, so kehre sich die Beweislast zu Ungunsten des Krankenhausträgers um. Zu berücksichtigen ist, dass bereits **der Nachweis, dass ein Arzt in mehreren Einzelfällen eines Operationstages Dokumentationen nachträglich erstellt und inhaltlich falsch dokumentiert hat, genügt, um den Beweiswert sämtlicher Dokumentationen dieses Arztes erheblich zu erschüttern.**

Die wesentlichen Regelungen

Dokumentationspflichten, §§ 630 f u. g BGB

Nichts neues!

- Bei elektronischer Aktenführung sicherstellen, dass bei Änderungen/Berichtigungen (zulässig) neben bisherigem Inhalt auch Zeitpunkt der Änderung sichtbar ist
- Angestellte Ärzte via AG Klärung wg. Software abfragen
- 100 % Sicherheit wird nicht verlangt

Die wesentlichen Regelungen

Beweislastregeln, § 630 h BGB

- Weiterhin **keine** generelle Beweislastumkehr
  - ⇒ Patient muss Behandlungsfehler beweisen i.S.v. Kausalität für Schaden
  - ⇒ Bloße Kodifikation der bisherigen Rechtsprechung
- Dies gilt auch bei Beweislastumkehr bei groben Behandlungsfehler und im sog. voll beherrschbarem Bereich (bspw. Funktionsfähigkeit technischer Geräte)

Die wesentlichen Regelungen

Zusammenfassung

- Viel alter Wein in neuen Schläuchen
- Extremforderungen wurden nicht umgesetzt
- Größtenteils „nur“ Klarstellungen / Akzentuierungen existenter Praxis u. Rechtsprechung
- Es bleibt abzuwarten, ob hierdurch die Rechtsprechung tendenziell nun zu einer strengeren, patientenfreundlicheren Auslegung neigen wird.